HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL I

DRA. DEBBIE WONG

EMBRIOGÉNESIS

- La pared primitiva se forma de ectodermo y mesodermo (somatopleura); en la 6.ª semana el mesodermo crece en dirección lateral y ventral como una lámina.
- Hacia la 7.ª semana ya se distinguen todos los músculos de la pared abdominal.

ETIOLOGÍA

- Multifactorial: enfermedad del tejido conectivo, tabaquismo, EPOC, actividad física y edad avanzada.
- Base común: debilitamiento de la fascia transversalis.

ZONAS DE DEBILIDAD

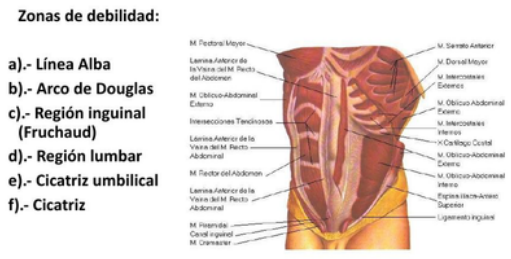
- Línea alba, arco de Douglas, región inguinal (Fruchaud), región lumbar, cicatriz umbilical y cicatrices quirúrgicas.

CLASIFICACIÓN

- Por etiología (congénita/adquirida), estadio (reductible/incarcerada), irrigación (estrangulada/no estrangulada) y localización (inguinal, umbilical, epigástrica, crural, lumbar, postincisional).

INCIDENCIA

- 10% de la población general; 90% inguinales o incisionales; hasta 2001, 850 000 reparaciones anuales.



HERNIA EPIGÁSTRICA

- Entre el xifoides y el ombligo, por los intersticios de la decusación de las fibras de la aponeurosis de los músculos planos en la línea media.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HERNIA INGUINAL

- Las más comunes; 25 veces más frecuentes en hombres; en hombres, indirectas:directas 2:1; en mujeres predominan las indirectas; las femorales (2,5% del total) son más frecuentes en mujeres.

HERNIA INGUINAL DIRECTA

- Dentro del triángulo de Hesselbach o medial a los vasos epigástricos; piso debilitado; más en ancianos.

HERNIA INGUINAL INDIRECTA

- Fuera del triángulo de Hesselbach o lateral a los vasos epigástricos; anillo inguinal profundo; la más frecuente; puede ser inguinoescrotal; congénita.

HERNIA FEMORAL O CRURAL

- Debajo del ligamento inguinal; la que más se complica; junto con la indirecta, mayor riesgo de estrangulamiento.



HERNIA UMBILICAL

- Lactantes: anillo umbilical grande o débil (10–30%), hasta 70% en prematuros; suele cerrar espontáneamente.
- Adulto: adquirida; 75% mujeres y 25% hombres; factores: embarazos repetidos, obesidad y aumento de la presión intraabdominal.

HERNIA DE SPIEGEL

- Representa ~1% de las hernias, en el borde externo de la línea semilunar; edad media 50 años; hasta 21.2% se presenta incarcerada.

HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL I

DRA. DEBBIE WONG

CAPAS DE LA PARED ABDOMINAL

- Piel; fascias de Camper, Scarpa y Gallaudet (vasos); aponeurosis del oblicuo mayor; músculos transverso y oblicuo menor; fascia transversalis; tejido conjuntivo preperitoneal; peritoneo.

PARTES DE UNA HERNIA

- Saco, contenido y anillo.

FISIOPATOLOGÍA

- Disminución de hidroxiprolina (colágeno) y defecto de hidroxilación de la molécula de colágeno; el 50% de los fibroblastos cultivados proliferaban.

FACTORES QUE AUMENTAN LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL

- Embarazo, ascitis, obesidad, obstrucción intestinal, esfuerzo defecatorio, prostatismo y ejercicio con pesas; además tabaquismo, edad y atrofia muscular.

DATOS CLÍNICOS DE LA HERNIA INGUINAL

- Aumento de volumen inguinal que crece con el esfuerzo, disminuye con el reposo y se asocia a dolor.

EXPLORACIÓN DE LA HERNIA INGUINAL

- Diagnóstico por examen físico: explorar canal inguinal y región crural, introducir el dedo y pedir que puje; distinguir reductible de irreductible.

CLÍNICA DE LA HERNIA UMBILICAL

- Lactantes: protrusión al llorar. Ardor, dolor cólico, exacerbación con la tos, ulceración o dermatitis; masa protruyente al examen.
- 10% de los adultos tiene antecedente de hernia en la infancia; 2,4% de las hernias de pared.

COMPLICACIONES DE LA HERNIA UMBILICAL

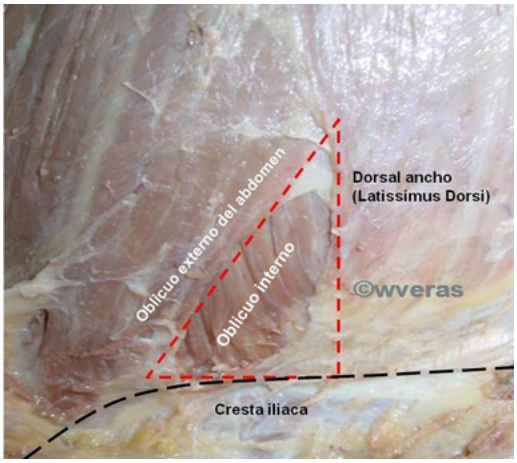
- Hematoma local, infección de la herida y recidiva <5%.

TRIÁNGULO DE GRYNFELTT-LESSHAFT

- Triángulo lumbar superior, más grande y constante; sitio más común de hernias lumbares espontáneas.
- Hernia justo inferior a la 12.ª costilla.

TRIÁNGULO DE PETIT

- Triángulo lumbar inferior (77% de los adultos): base en la cresta ilíaca, borde lateral el oblicuo externo y medial el dorsal ancho.
- Hernia justo por encima de la cresta ilíaca.



HERNIA DE RICHTER

- Incarcerada con pinzamiento del borde antimesentérico del intestino delgado: solo se estrangula parte de la circunferencia de la pared.

HERNIA DE LITTRE

- Presencia de un divertículo de Meckel en cualquier saco herniario.

HERNIA DE AMYAND

- Contiene el apéndice cecal inflamado a través de un defecto herniario inguinal.

HERNIA POSTINCISIONAL

- Protrusión del peritoneo por separación de los bordes de una herida musculoaponeurótica.
- Factores: obesidad, infección, dehiscencia, hematoma o seroma, técnica deficiente de cierre y desnutrición.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

- Reposición del contenido herniario, resección del saco y reconstrucción de la pared.

